

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN DEPRESIÓN (QLDS)

Eje IV: Calidad de Vida y Funcionamiento • Modelo de Satisfacción de Necesidades Humanas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Calidad de Vida para la Depresión (QLDS).
Nombre Original	Quality of Life in Depression Scale (QLDS; Hunt & McKenna, 1992).
Autores Originales	Sonja M. Hunt, Ph.D. y Stephen P. McKenna, Ph.D. (Galen Research / Univ. Manchester).
Adaptación Hispana	Bobes, Bulbena, Luque et al. (1997, 2004); Validación en población psiquiátrica española.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Impacto de la depresión en necesidades vitales.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme específico para trastornos depresivos.
Formato y Reactivos	34 reactivos en formato dicotómico autoadministrado (Verdadero / Falso; Sí / No).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) con diagnóstico de episodio depresivo mayor, distimia o recurrencia.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de cumplimentación autónoma.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para práctica clínica sin ánimo de lucro y ensayos de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: MODELO DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

La **QLDS** fue formulada por Hunt y McKenna (1992) fundamentándose en el **Modelo de Satisfacción de Necesidades Humanas** (Need Satisfaction Model), superando las limitaciones de los inventarios sintomáticos genéricos:

- Postulado Esencial:** La calidad de vida se define operativamente como el grado en que el sujeto es capaz de satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales fundamentales. La patología depresiva actúa como una barrera restrictiva que frustra la satisfacción de estas demandas esenciales.
- Diferenciación Síntoma vs. Calidad de Vida:** A diferencia del inventario de Beck (BDI) o Hamilton (HAM-D), la **QLDS** no cuantifica la intensidad del afecto disfórico o el insomnio per se, sino cómo dichos fenómenos impiden el ejercicio de la autonomía, la reciprocidad afectiva, la autoestima y la autorrealización personal.
- Centrado en el Paciente:** Los 34 reactivos derivaron directamente de entrevistas cualitativas en profundidad con pacientes depresivos en recuperación, capturando el lenguaje experiencial genuino del cuadro.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (34 ÍTEMS DICOTÓMICOS)

El instrumento evalúa 6 dimensiones clave de necesidad frustrada por la sintomatología depresiva:

Dimensión Vital	Nº Ítems	Contenido y Criterios Evaluados en el QLDS
1. Autonomía e Iniciativa	6 ítems	Pérdida de autodeterminación, dependencia de terceros, parálisis en toma de decisiones.
2. Interacción y Red Social	7 ítems	Aislamiento voluntario, evitación del contacto social, vergüenza ante conocidos.
3. Energía y Vitalidad	5 ítems	Fatiga patológica persistente, pesadez corporal que imposibilita actividades básicas.
4. Afecto y Disfrute Hedónico	6 ítems	Anhedonia profunda, incapacidad de disfrutar de aficiones habituales, apatía afectiva.
5. Autoestima y Valía	5 ítems	Sentimientos de carga para la familia, autorreproche, sensación de fracaso vital.
6. Seguridad y Proyección	5 ítems	Incertidumbre ante el porvenir, temor al colapso psíquico, desesperanza funcional.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La versión española adaptada y validada por Bobes et al. (1997, 2004) en pacientes con depresión mayor ambulatorios e ingresados acredita una elevada solidez metodológica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.91 - 0.94	Extraordinaria homogeneidad unifactorial en los 34 ítems dicotómicos.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.88 - 0.92	Excelente estabilidad temporal a las 2 semanas en fase de estabilidad clínica.
Sensibilidad al Cambio	d de Cohen = 1.15	Sensibilidad terapéutica superior a escalas genéricas (SF-36) tras 8 semanas de ISRS.
Validez Convergente	r = 0.74 - 0.79	Fuerte correlación con escalas de gravedad de síntomas (HAM-D 17, MADRS y BDI-II).
Validez Discriminante	t = 12.4, p < 0.001	Diferenciación robusta entre controles sanos, depresión leve y depresión severa.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

• **Opciones de Respuesta:** Formato binario dicotómico donde el paciente marca si la afirmación se aplica a su estado actual: Sí (1) o No (0). • **Regla de Puntuación:** Todos los reactivos están redactados en sentido de disfunción o restricción vital. Cada respuesta afirmativa ("Sí") recibe 1 punto; la respuesta negativa ("No") recibe 0 puntos. • **Cálculo de la Puntuación Directa (PD):** Se suma linealmente la totalidad de los reactivos afirmativos:

$$\text{Puntuación Total QLDS} = \sum_{i=1}^{34} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 34 puntos})$$

• **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación directa, **menor calidad de vida** y mayor déficit en la satisfacción de necesidades básicas. La puntuación 0 refleja preservación funcional plena.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango QLDS	Percentil	Significación Clínica y Nivel de Compromiso
Preservada / Normal	0 a 8 pts	P1 - P25	Calidad de vida adecuada; necesidades cubiertas sin interferencia depresiva.
Deterioro Leve	9 a 16 pts	P26 - P50	Interferencia moderada en ocio y vitalidad; autonomía preservada.
Deterioro Moderado	17 a 25 pts	P51 - P75	Frustración notable de necesidades; aislamiento y pérdida de iniciativa.
Deterioro Severo	26 a 34 pts	> P75	Colapso de calidad de vida; anhedonia extrema, aislamiento y dependencia.

CRITERIO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL COMPLETA (QLDS ≤ 8): En estudios clínicos de efectividad de antidepresivos y psicoterapia, se considera **recuperación de la calidad de vida** una puntuación final en el QLDS ≤ 8 puntos. Si el paciente alcanza remisión sintomática en HAM-D (≤ 7) pero puntúa > 16 en QLDS, persiste una cicatriz funcional residual que anticipa recaídas tempranas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA EN DEPRESIÓN

FLUJOGRAMA DE DECISIÓN TERAPÉUTICA MEDIANTE QLDS:

- **Paso 1 (Línea Base en Depresión Mayor):** Administrar QLDS al inicio del tratamiento farmacológico o cognitivo-conductual (típicamente puntuaciones directas > 24).
- **Paso 2 (Control a las 6-8 Semanas):** Cuantificar la reducción de puntos:
 - **Reducción $\geq 50\%$ de la puntuación inicial:** Buena respuesta de calidad de vida; mantener pauta terapéutica.
 - **Reducción $< 30\%$ persistiendo QLDS > 18 :** Fracaso en restauración funcional; evaluar cambio de fármaco o intensificación psicoterapéutica (activación conductual).
- **Paso 3 (Descarte de Síntomas Residuales):** Inspeccionar reactivos de fatiga y retraimiento social para discriminar efectos sedativos de la medicación frente a inercia depresiva.
- **Paso 4 (Mantenimiento y Alta):** Requerir mantenimiento estable de QLDS ≤ 8 durante al menos 6 meses antes del retiro gradual de antidepresivos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN DEPRESIÓN RESIDUAL

Identificación: Mujer de 44 años, abogada en ejercicio, tratada por episodio depresivo mayor recurrente con Sertralina 150 mg/día. Si bien la escala Hamilton-D descendió a 9 (remisión parcial sintomática), persiste queja de “sentirse como un autómatas incapaz de conectar con sus hijos o de disfrutar de su profesión”. **Evaluación Inicial con QLDS:**

- **Puntuación Directa = 27 / 34 puntos (Deterioro Severo de Calidad de Vida, Percentil 85).**
- **Ítems afirmativos críticos:** “Siento que soy una carga para los demás”, “Me cuesta tomar cualquier decisión sencilla”, “Evito encontrarme con amigos”, “Siento que he perdido el control de mi vida”.

Intervención Clínica: Se inició Psicoterapia Cognitivo-Conductual enfocada en reestructuración de autoexigencia y Activación Conductual gradual estructurada, combinada con potenciación psicofarmacológica con Bupropión 150 mg/día para contrarrestar el aplanamiento dopaminérgico. **Reevaluación a las 12 Semanas:** La puntuación en QLDS descendió a **6 / 34 puntos (Calidad de Vida Preservada)**. La paciente reanudó sus proyectos profesionales, reactivó su vida social y verbalizó una recuperación plena de su sentido de autonomía y disfrute familiar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISOCIACIÓN SÍNTOMA-FUNCIÓN: Una remisión sintomática sin mejoría paralela en QLDS (> 16) alerta de embotamiento afectivo iatrogénico o cronificación de conductas de evitación fóbica depresiva.

DIFERENCIAL CON TRASTORNO ADAPTATIVO: En duelos y adaptativos, el QLDS muestra fluctuaciones rápidas ante estímulos gratificantes, a diferencia del bloqueo rígido de necesidades en la melancolía.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Hunt, S. M., & McKenna, S. P. (1992). The QLDS: A scale for the assessment of quality of life in depression. *Health Policy*, 22(3), 307-319.
2. McKenna, S. P., Hunt, S. M., & Tennant, A. (1995). The development of a Spanish version of the Quality of Life in Depression Scale (QLDS). *Social Science & Medicine*, 41(5), 653-659.
3. Bobes, J., Bulbena, A., Luque, A., et al. (2004). Evaluación de la calidad de vida en pacientes con depresión: Validación de la versión española del QLDS. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 32(3), 143-151.
4. Tuunainen, A., et al. (2001). Quality of life in depression: Validation of the QLDS in Finnish clinical psychiatric practice. *Quality of Life Research*, 10(6), 507-514.